

Injúria renal aguda · abordagem

IRA = queda abrupta da TFG com retenção de escórias. Separe pré-renal, parenquimatosa e obstrutiva; trate causa, volume e hipercalcemia antes de 'só pedir creatinina de novo'.

Pistas de classificação

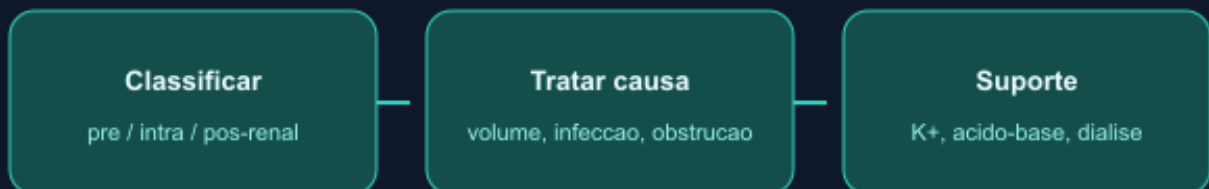
Lembre - Pistas de classificação

Pré-renal: hipovolemia/baixo débito, FENa baixa, urina concentrada — responde a volume se rim íntegro. Intrínseca: NTA, glomerulonefrite, AINEs/contraste. Pós-renal: globo, HBP, cálculos bilaterais — USG de vias urinárias.

Fluxo de prova: volume/perfusão !' excluir obstrução !' manejar complicações e nefrotóxicos.

Abordagem da IRA

Classificar -> tratar causa -> suporte



Conduta prática

- Rever medicações: IECA/BRA, AINE, diuréticos, aminoglicosídeo, contraste
- Volume: cristaloides se hipovolemia; evitar sobrecarga no anúrico
- USG renal se suspeita obstrutiva ou causa não óbvia
- Monitorar diurese, K z, ECG, bicarbonato e ureia

Indicações clássicas de diálise (AEIOU)

Letra | Indicação

- A | Acidose metabólica refratária
- E | Eletrólitos (hiperK refratária)
- I | Intoxicações dialisáveis
- O | Overload (edema pulmonar refratário)
- U | Uremia sintomática (pericardite, encefalopatia)

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Hipercalcemia com alterações no ECG é emergência — cálcio EV estabiliza membrana antes de 'só pedir gasometria de novo'. Insulina+glicose, beta-agonista e diálise conforme resposta.